

GUÍA CLÍNICA

Recursos Terapéuticos para la Ansiedad Infantil

20 actividades clínicas listas para la sesión

Niños de 4 a 10 años

Recursos terapéuticos para el uso directo en sesión con niños ansiosos.

Cada actividad se apoya en la literatura clínica sobre ansiedad infantil: protocolos de TCC, ACT, exposición gradual, neurociencia del desarrollo y regulación somática.

Abarcan desde la primera consulta y la construcción del vínculo hasta el cierre terapéutico, pasando por las manifestaciones más frecuentes: fobias específicas, ansiedad de separación, social, de desempeño, generalizada, nocturna, de salud, perfeccionismo, rumiación y ansiedad reactiva.

Este documento reúne los recursos 1 a 20; los recursos 21 a 40 están en los archivos complementarios del kit.

Terapia cognitivo-conductual

ACT

Exposición gradual

Regulación somática

Índice de recursos



Cada recurso incluye objetivo, pasos de aplicación, lectura clínica, preguntas orientadoras y adaptaciones.

- 01 **El Primer Encuentro con la Ansiedad** — Rapport y vínculo en las primeras sesiones
- 02 **El Monstruo de la Ansiedad** — Externalizar y dar forma a la ansiedad para reducir su amenaza
- 03 **La Escalera del Miedo** — Jerarquía de exposición gradual a situaciones evitadas
- 04 **El Termómetro del Coraje** — Monitoreo longitudinal de la ansiedad y del enfrentamiento
- 05 **La Respiración del Dragón** — Psicoeducación sobre la ansiedad y respiración regulatoria
- 06 **El Miedo que Pasa** — Fobias específicas: fenómenos naturales, animales y objetos
- 07 **La Vergüenza que Aprieta** — Vergüenza y ansiedad social temprana en niños pequeños
- 08 **El Ancla del Tacto** — Regulación emocional por vía táctil
- 09 **Cuando la Comida Asusta** — Ansiedad al tragar, atragantarse y comer
- 10 **Lo que Pasó Ayer** — Ansiedad reactiva a un episodio puntual: susto, accidente o escena perturbadora
- 11 **El Diario de los Pequeños Valientes** — Registro de enfrentamientos reales
- 12 **Lo que Puedo Controlar** — Círculo de control para niños ansiosos
- 13 **El Personaje Valiente** — Alter ego para el enfrentamiento
- 14 **El Cuerpo en Pausa** — Grounding para crisis de ansiedad
- 15 **La Entrevista con la Ansiedad** — Externalización y desmitificación
- 16 **La Bomba de Energía** — Activación conductual contra la evitación ansiosa
- 17 **La Conversación con los Padres** — Enseñar a la familia a no reforzar la evitación
- 18 **El Álbum de las Veces que Lo Logré** — Banco de evidencias de competencia
- 19 **El Barómetro de la Situación** — Evaluar el riesgo real vs. el riesgo percibido
- 20 **Cerrando el Tratamiento** — Ritual de alta para la ansiedad

TIPO	Protocolo de acogida y establecimiento de la alianza terapéutica con el niño ansioso
EDAD	4 a 10 años
DEMANDA	Primera sesión o fases iniciales — niño que llega resistente, monosilábico, pegado al adulto, que observa todo sin involucrarse o que pone a prueba el ambiente antes de participar
DURACIÓN	50 a 60 minutos — sesiones iniciales de vínculo
MATERIALES	Materiales lúdicos variados disponibles en el espacio; sin materiales estructurados obligatorios

Objetivo

Establecer la alianza terapéutica con el niño ansioso, que suele llegar al consultorio en estado de hipervigilancia, evaluando el ambiente y al adulto desconocido antes de involucrarse en cualquier actividad. El error clínico más común en las primeras sesiones es el exceso de estructura y de preguntas: un adulto desconocido que enseguida propone actividades, pregunta sobre la ansiedad e intenta «resolver el problema» activa justamente el sistema de alarma que el niño ya trae hiperactivado. La investigación sobre alianza terapéutica con niños (Shirk y Karver, entre otros) muestra que la calidad del vínculo en las primeras sesiones es uno de los predictores más robustos del resultado, sin importar el enfoque. Con niños ansiosos, ese vínculo se construye mediante la previsibilidad, la ausencia de presión para rendir y la experiencia de que el adulto es seguro y no evaluador.

Cómo aplicar

1

Sesión 1 — El ambiente habla antes que usted (primeros 10 min)

Antes de que el niño entre, organice el espacio para comunicar seguridad y elección: materiales variados disponibles, pero nada forzado sobre la mesa. Cuando entre, no vaya hacia él de inmediato. Déjelo entrar y observar el ambiente 1 o 2 minutos sin abordarlo. Solo diga: «Podés mirar todo. Este también es tu espacio». Esa espera activa —respetar su tiempo de escanear el ambiente— es la primera señal de que no va a forzar su ritmo.

2

Sesión 1 — Seguir la iniciativa del niño (20 a 30 min)

En las primeras sesiones, siga lo que el niño elige hacer; no dirija. Si toma un juguete, jueguen juntos sin interpretar. Si quiere estar en silencio, quédese. Si empieza a hablar de algo no relacionado con la ansiedad, escuche con interés genuino. Evite preguntas sobre la ansiedad, sobre por qué vino o sobre qué siente. Preguntas abiertas seguras: «¿Qué es lo que más te gusta hacer?» / «¿Hay algo en lo que seas muy bueno?» / «Contame sobre [tema que trajo]». El objetivo es que el niño experimente el consultorio como un lugar seguro, no recolectar una anamnesis completa.

3

Sesión 2 en adelante — Introducción gradual de la ansiedad (10 min)

Cuando haya vínculo suficiente —el niño llega sin resistencia, se involucra, lo busca— introduzca el tema de forma lateral y no amenazante: «Estuve pensando en vos esta semana. Viniste acá porque a veces te agarra esa sensación de panza apretada, ¿no? Contame cómo estuvo tu semana». Nombrar el síntoma físico antes que la emoción es menos amenazante para el niño ansioso que preguntar directo por los sentimientos.

A lo largo — Volver el consultorio previsible (continuo)

Mantenga una estructura consistente: mismo orden de inicio, mismo ritual de cierre, aviso del tiempo antes de terminar («faltan 5 minutos»). Cuando proponga algo nuevo, avise antes: «Hoy quería probar algo distinto. ¿Querés escuchar primero qué es antes de decidir?». La elección y el aviso previo son reguladores fundamentales para el niño ansioso.

Lectura clínica

La velocidad con que el niño se involucra en las primeras sesiones es un dato diagnóstico importante. Un niño que tarda muchas sesiones en involucrarse puede tener ansiedad más severa, historial de experiencias negativas con adultos o un apego muy inseguro. Observe también la diferencia entre el niño ansioso y el opositor: el ansioso suele querer agradar pero teme equivocarse; el opositor desafía activamente. Las estrategias de enganche son distintas para cada perfil.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué te gusta hacer acá que no hacés en otros lugares?
- ¿Cómo estuvo la semana? ¿Hay algo que quieras contarme?
- ¿Hay algo acá en el consultorio que no te gusta o que te incomoda?
- ¿Qué pensás que va a pasar acá? ¿Qué te imaginaste antes de venir?
- ¿Hay algo que necesites que yo sepa para sentirte más cómodo?

Adaptaciones

Para niños que se niegan por completo a entrar sin los padres: no fuerce la separación las primeras veces. Empiece con los padres presentes y redúzcalo gradualmente.

Para niños muy pequeños (4 a 5 años): las primeras sesiones pueden ser enteramente de juego libre, sin más estructura ni objetivo que volver el espacio familiar y seguro.

TIPO	Técnica de externalización narrativa con creación de personaje — base para las intervenciones siguientes
EDAD	4 a 9 años
DEMANDA	Ansiedad en cualquier manifestación — especialmente indicada en las primeras sesiones como primer paso de externalización y nombramiento de la ansiedad
DURACIÓN	35 a 45 minutos
MATERIALES	Hoja en blanco, marcadores, lápices de colores

Objetivo

Externalizar la ansiedad, transformándola de una experiencia interna difusa y amenazante en una entidad con forma, nombre y características definidas. La externalización, técnica central de la Terapia Narrativa de White y Epston, cumple una función clínica específica: cuando la ansiedad es interna y sin forma, el niño se identifica con ella («soy ansioso»), la ansiedad es quien él es. Cuando gana forma externa —un monstruo, una niebla, un personaje— el niño se separa de ella («tengo un monstruo que a veces me visita»). Esa separación entre identidad y síntoma es clínicamente transformadora. El acto de dibujar el monstruo a menudo ya reduce la ansiedad: lo que puede verse y describirse es menos amenazante que lo que permanece indefinido e interno.

Cómo aplicar

1

Presentación de la idea de externalización (5 min)

Presente con lenguaje simple: «¿Conocés esa sensación fea que aparece a veces, el corazón que se acelera, la panza que se aprieta? Hoy vamos a encontrar la forma de ver esa sensación por fuera, como si la pusieramos en una hoja de papel para poder mirarla». No la nombre todavía como «ansiedad» si el niño no usa ese término: siga su lenguaje —«los nervios», «el miedo», «esa cosa».

2

Creación del monstruo (20 min)

Pida al niño que dibuje la forma de la ansiedad: puede ser un monstruo, un animal, una figura geométrica, una niebla. «¿Cómo sería si esos nervios tuvieran un cuerpo? ¿Cómo sería?». Mientras dibuja, haga preguntas que enriquecen el personaje: ¿de qué tamaño?, ¿qué colores tiene?, ¿tiene dientes?, ¿hace ruido?, ¿qué hace cuando llega?, ¿qué quiere de vos?, ¿qué no le gusta? Cada respuesta es información clínica sobre cómo el niño experimenta la ansiedad.

3

Ponerle nombre al monstruo (5 min)

Pida que el niño le dé un nombre al monstruo —no «ansiedad», sino un nombre inventado por él—. El nombre personaliza la externalización y crea continuidad entre sesiones: en las próximas podrá preguntar «¿cómo estuvo [nombre] esta semana?», lo cual es mucho más accesible emocionalmente.

La primera pregunta sobre la relación (5 min)

«¿Quién manda más, vos o [nombre]?». Si el niño dice que manda el monstruo: «Al principio es así. Pero vamos a descubrir juntos cómo podés ser más fuerte que él». Si dice que manda él, celébrelo y pregunte: «¿Cómo lo hacés? ¿Qué descubriste que a él no le gusta?».

Lectura clínica

El monstruo que el niño crea es uno de los materiales proyectivos más ricos de todo el tratamiento. Monstruos muy grandes y amenazantes indican que el niño se siente dominado por la ansiedad. Monstruos con características de control (que atan, que sujetan) revelan la experiencia de parálisis conductual. Guarde el dibujo: puede retomarse a lo largo del tratamiento como termómetro del progreso.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué hace el monstruo cuando llega? ¿Cómo te das cuenta de que está llegando?
- ¿En qué situación aparece más el monstruo?
- ¿Hay algo que haga que el monstruo se achique o se vaya?
- ¿El monstruo alguna vez te ayudó de alguna forma, aunque sea chiquita?
- Si el monstruo pudiera hablar, ¿qué pensás que diría?

Adaptaciones

Para niños que rechazan el formato de monstruo («eso es de chiquitos»): ofrezca alternativas —una niebla, una sombra, un personaje de videojuego—. El mecanismo de externalización es el mismo; el formato es adaptable.

Para niños que crean monstruos muy aterradores que aumentan la ansiedad: redirija hacia algo menos amenazante.

TIPO	Construcción de jerarquía de exposición y plan de enfrentamiento gradual — base del tratamiento conductual de la ansiedad
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Ansiedad con evitación establecida — niño que evita sistemáticamente situaciones, objetos o contextos; cualquier subtipo de ansiedad con componente de evitación
DURACIÓN	40 a 50 minutos — construcción en sesión; implementación gradual a lo largo del tratamiento
MATERIALES	Hoja con una escalera dibujada (8 a 10 escalones), marcadores, regla de ansiedad de 0 a 10

Objetivo

Construir una jerarquía de exposición gradual, el componente con mayor respaldo empírico en el tratamiento de todos los trastornos de ansiedad infantil. La exposición gradual funciona por habituación y extinción del miedo condicionado: cuando el niño se expone a la situación temida sin que ocurra la consecuencia catastrofizada, el sistema límbico aprende que el estímulo no es realmente peligroso. Rothbaum y Foa demostraron que la exposición es necesaria para la extinción del miedo: ninguna cantidad de reestructuración cognitiva reemplaza la experiencia directa de que la situación temida es tolerable. El error más común es empezar por los escalones más difíciles, lo que produce una activación intensa que impide el aprendizaje de extinción.

Cómo aplicar

1

Identificación de todas las situaciones evitadas (10 min)

Haga un inventario completo de las situaciones que el niño evita o enfrenta con mucha ansiedad: «¿Qué evitas hacer por culpa del [monstruo/nervios/miedo]? ¿Hay lugares a los que no vas? ¿Cosas que dejaste de hacer?». Incluya todo, de lo más chico a lo más grande, y también lo que enfrenta pero con mucha ansiedad.

2

Evaluación de cada situación (10 min)

Para cada situación, el niño le pone una nota de 0 a 10 en la regla de ansiedad: «Si tuvieras que enfrentar esto ahora, ¿cuántos nervios sentirías? Cero es ningún nervio, diez es el peor nervio que sentiste en tu vida». Esta evaluación (escala SUDS de unidades subjetivas de malestar) organiza la jerarquía.

3

Construcción de la escalera (10 min)

Ubique las situaciones en los escalones, del menos asustador (abajo, SUDS 1-3) al más asustador (arriba, SUDS 8-10). Explique: «Empezamos por los escalones de abajo. Cada escalón que subís se vuelve más fácil porque ya probaste que el de abajo era posible. Nadie escala una montaña empezando por la cima».

Planificación del primer escalón (10 min)

Elijan el primer escalón (SUDS 3-4). Armen un plan concreto: cuándo lo va a intentar, con quién, por cuánto tiempo, qué hará si la ansiedad sube mucho. Diga: «No necesitas sentirte bien para subir un escalón. Necesitas sentir el nervio manejable. El objetivo no es no tener nervios, es hacerlo a pesar de los nervios».

Lectura clínica

La precisión de los SUDS iniciales es un dato diagnóstico importante. Un niño que puntúa todo muy alto tiene dificultad para discriminar intensidades. La escalera es un documento vivo: revísela en cada sesión. Cuando un escalón se conquista, márkelo con otro color y celébrelo. El registro visual del progreso es uno de los refuerzos más motivadores del tratamiento.

Preguntas orientadoras

- ¿Cuál es el escalón que más querés poder subir? ¿Qué cambiaría en tu vida si lo lograras?
- ¿Cuál es el escalón que ahora parece más imposible?
- Cuando ya subiste un escalón, ¿cómo te sentiste después? ¿Valió la pena el nervio?
- ¿Qué necesitas que yo haga para ayudarte a subir el próximo escalón?
- ¿Hay algún escalón que ya estás subiendo sin darte cuenta?

Adaptaciones

Para niños que se niegan a construir la escalera porque «nunca voy a poder»: empiece con un único escalón SUDS 2.

Para fobias específicas: la escalera puede ser muy detallada, con muchos escalones intermedios; cuanto más fóbica, más escalones intermedios necesita la jerarquía.

TIPO	Instrumento de autoevaluación y monitoreo clínico de uso sistemático durante todo el acompañamiento
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Uso en todas las sesiones del acompañamiento — evaluación de proceso y de resultado
DURACIÓN	10 a 15 minutos al inicio de cada sesión
MATERIALES	Ficha con dos termómetros paralelos: ansiedad (0 a 10) y coraje (0 a 10)

Objetivo

Monitorear de forma sistemática dos ejes centrales del tratamiento —la intensidad de la ansiedad y el nivel de enfrentamiento (coraje)— a lo largo de todo el acompañamiento. El instrumento de monitoreo suele descuidarse en el trabajo con niños a favor de la impresión clínica subjetiva, que es insuficiente porque la percepción de progreso está muy influida por el estado actual y la memoria selectiva. El termómetro con registro gráfico en el tiempo crea un documento objetivo de progreso. Clínicamente también comunica algo fundamental: el objetivo del tratamiento no es llevar la ansiedad a cero, sino aumentar el coraje, la capacidad de actuar a pesar de la ansiedad. Ese encuadre, alineado con la filosofía ACT, es más realista y más empoderador que la promesa de eliminar la ansiedad.

Cómo aplicar

1

Estructura del termómetro (preparar antes de la primera aplicación)

Dos termómetros paralelos. Termómetro 1 — Ansiedad: 0 = «los nervios casi no aparecieron»; 5 = «aparecieron bastante y a veces fue difícil»; 10 = «fue muy intenso, dominó la semana». Termómetro 2 — Coraje: 0 = «evité todo lo que los nervios me mandaron evitar»; 5 = «enfrenté algunas cosas pero hui de otras»; 10 = «hice casi todo lo que quería aun con nervios». Debajo de cada termómetro, un espacio para una frase explicativa.

2

Aplicación semanal al inicio de la sesión (10 min)

El niño marca los dos termómetros al comienzo de cada sesión. Para cada marca: «¿Por qué ese número y no uno más arriba o más abajo?». Anote los números en una tabla longitudinal. El par informa más que cada uno por separado: ansiedad alta + coraje alto indica un niño que enfrenta a pesar de la dificultad — excelente pronóstico—. Ansiedad baja + coraje bajo puede indicar evitación exitosa: una falsa mejora.

3

Uso longitudinal de los datos (a partir de la cuarta sesión)

Muéstrele al niño el gráfico de evolución: «¿Qué notás cuando ves estos números juntos?». El gráfico suele revelar patrones que el niño no percibía: que la ansiedad sube antes de fechas específicas, que el coraje sube aunque la ansiedad no baje. Cada observación del niño sobre su propio gráfico es un ejercicio de metacognición.

Lectura clínica

Un tratamiento que funciona tiende a mostrar: ansiedad estable o con leve reducción y coraje que aumenta progresivamente —el coraje crece antes de que baje la ansiedad; la ansiedad baja después—. Cuando el coraje no sube a lo largo de muchas sesiones, investigue barreras: ¿se está practicando la jerarquía de exposición fuera de la sesión?, ¿la familia está reforzando la evitación?

Preguntas orientadoras

- ¿Por qué marcaste ese número en el termómetro de la ansiedad y no uno más o uno menos?
- Mirando los dos termómetros juntos, ¿qué notás?
- ¿Cuál fue el momento de la semana en que el nervio estuvo más alto?
- Comparando con el comienzo del tratamiento, ¿qué muestran estos números?
- Si pudieras cambiar solo uno de los termómetros esta semana, ¿cuál cambiarías?

Adaptaciones

Para niños que marcan siempre el mismo número: puede ser rigidez cognitiva o miedo a que reconocer una mejora signifique dejar el tratamiento. Explórelo directo: «¿Pensás que si decís que estás mejor vas a tener que dejar de venir?».

TIPO	Psicoeducación sobre la ansiedad e instalación de la primera herramienta de regulación autonómica
EDAD	4 a 9 años
DEMANDA	Primeras sesiones de cualquier cuadro ansioso — instalación de la primera herramienta de regulación y psicoeducación sobre lo que pasa en el cuerpo con la ansiedad
DURACIÓN	30 a 40 minutos — ensayo en sesión; práctica diaria de 3 minutos
MATERIALES	Ninguno obligatorio; opcional: burbujas de jabón para demostrar la espiración larga

Objetivo

Ofrecer al niño la primera herramienta concreta de regulación autonómica —la respiración con espiración prolongada— integrada a una psicoeducación sobre la ansiedad accesible y desmitificadora. La respiración es la puerta de entrada más indicada para el trabajo de regulación con niños pequeños: está siempre disponible, actúa directamente sobre el sistema nervioso autónomo sin exigir capacidad cognitiva avanzada y se enseña en una sola sesión. El mecanismo fisiológico es directo: la espiración prolongada activa el nervio vago, que estimula el sistema nervioso parasimpático, que inhibe la respuesta de alarma simpática. La metáfora del dragón vuelve intuitiva y divertida la respiración diafragmática para niños de 4 a 8 años.

Cómo aplicar

1

La psicoeducación de la alarma (10 min)

«¿Sabés qué es una alarma de incendio? El cuerpo tiene una alarma igual. Cuando cree que hay peligro —aunque no lo haya— se enciende. El corazón late más rápido, la panza se aprieta, las manos se enfrían. Esa es la alarma preparándote para correr o pelear. El problema es que a veces se enciende sin que haya fuego de verdad —cuando hay una prueba, cuando hay un lugar nuevo—. La buena noticia es que hay una forma de apagar la alarma: la respiración».

2

Enseñar la respiración del dragón (15 min)

«Te muestro cómo respira el dragón. Primero llena la panza de fuego —inspira por la nariz contando hasta 4, la panza va hacia adelante (no el pecho)—. Después suelta el fuego por la boca —cuenta hasta 6 u 8, bien despacio, como si soplaras una velita o hicieras una burbuja de jabón—. Practiquen juntos 5 ciclos. Use burbujas si tiene: la espiración que arma una burbuja es naturalmente larga y controlada.

3

Identificar el efecto en el cuerpo (5 min)

Después de los 5 ciclos: «¿Qué pasó en tu cuerpo después de respirar como el dragón? ¿Quedó distinto de antes?». La mayoría nota alguna diferencia. Nombrar ese efecto es fundamental: el niño necesita crear la asociación «respiré como el dragón → mi cuerpo quedó más tranquilo» para usar la herramienta de forma autónoma.

Instalación de la práctica diaria (5 min)

Acuerde una práctica diaria de 3 minutos —no solo en momentos de ansiedad, sino como entrenamiento regular—. «Si entrenás cuando estás tranquilo, va a funcionar mejor cuando lo necesites de verdad. Es como entrenar para un deporte: no aprendés a jugar al fútbol recién en el momento del partido».

Lectura clínica

Observe la calidad de la respiración. La respiración torácica (solo sube el pecho) reduce mucho la eficacia. Un niño que hiperventila al intentar la espiración larga —mareo u hormigueo— necesita un ritmo más lento. Un mareo leve es normal y se debe a la reducción de CO₂.

Preguntas orientadoras

- Después de respirar como el dragón, ¿qué notaste distinto en tu cuerpo?
- ¿En qué momento del día pensás que vas a usar la respiración del dragón?
- ¿Pudiste usarla fuera de la sesión? ¿Qué pasó?
- ¿La alarma del cuerpo bajó después de respirar? ¿Cuánto?
- ¿Hay alguna situación donde te parece que sería más útil?

Adaptaciones

Para niños muy pequeños (4 a 5 años): use burbujas de jabón como soporte concreto.

Para niños que la encuentran «boba»: «Atletas de alto rendimiento, cirujanos y pilotos de caza usan exactamente esta respiración. No es boba: es lo que saben hacer los mejores».

TIPO	Protocolo de exposición gradual para fobia específica con psicoeducación y jerarquía de aproximación
EDAD	4 a 10 años
DEMANDA	Fobia específica — miedo intenso y desproporcionado a truenos, relámpagos, insectos, perros, agujas, vómito o sangre, que causa evitación significativa o sufrimiento intenso en la exposición
DURACIÓN	40 a 50 minutos — más exposiciones graduales a lo largo de las sesiones
MATERIALES	Materiales variados según el estímulo fóbico: imágenes progresivas, sonidos grabados, objetos a distancia progresiva

Objetivo

Tratar la fobia específica infantil con el protocolo de exposición gradual, el que cuenta con mayor evidencia de toda intervención psicológica —con tasas de respuesta superiores al 90% en niños con fobia específica aislada, según los metaanálisis de Ollendick y colaboradores—. La fobia específica es clínicamente distinta de los demás trastornos ansiosos: tiene un estímulo desencadenante claramente identificable y circunscrito. El mecanismo de mantenimiento es la evitación que impide la extinción: el miedo solo baja cuando el organismo aprende, por experiencia directa, que el estímulo no causa el daño temido. Cada vez que el niño evita, el miedo se refuerza negativamente.

Cómo aplicar

1

Evaluación de la fobia específica (10 min)

Mapee con precisión: ¿cuál es el estímulo exacto? (No «perros» sino «perros grandes que ladran»). ¿Cuánto hace que la tiene? ¿Hubo un evento desencadenante? ¿Cuál es el grado de evitación? ¿Cuál es la creencia catastrófica central: «¿Qué pensás que va a pasar si no podés evitarlo?». Esa creencia es el objetivo cognitivo.

2

Psicoeducación sobre el estímulo fóbico (10 min)

Aporte información factual que contradiga la creencia catastrófica. Para truenos: «El trueno es el ruido del rayo, que ya pasó. El ruido en sí no te lastima». Para perros: «Los perros que ladran suelen estar asustados o excitados, no necesariamente agresivos». Para agujas: «El dolor dura menos de 3 segundos». Valide el miedo antes de dar la información.

3

Construcción de la jerarquía específica (15 min)

Construya una jerarquía muy detallada. Para fobia a los perros: imagen de perro chico → video de perro tranquilo → perro real del otro lado de la calle → a 5 metros → a 2 metros con dueño → tocar un perro tranquilo. Cada escalón con un SUDS 2 a 3 por encima del anterior: lo bastante gradual para que cada exposición sea manejable y ocurra el aprendizaje de extinción.

Primera exposición en sesión (10 min)

Realice la primera exposición con el estímulo del escalón más bajo —por lo general una representación (imagen, sonido grabado)—. Instruya: «Vamos a quedarnos con esto 2 minutos. La ansiedad va a subir al principio y después va a empezar a bajar. Eso es tu cerebro aprendiendo que no hay peligro de verdad».

Lectura clínica

El factor más crítico es que el niño permanezca en contacto con el estímulo hasta que la ansiedad empiece a bajar: no puede huir en el pico. Huir en el pico refuerza el miedo más que si no lo hubiera intentado. Las fobias con alta valencia de asco (sangre, insectos, vómito) tienen un mecanismo distinto: involucran el sistema del asco, más resistente a la habituación simple.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué pensás que va a pasar si no podés evitar [estímulo]?
- ¿Cuántas veces te expusiste y pasó lo que temías?
- Después de que la ansiedad empezó a bajar durante la exposición, ¿qué notaste?
- ¿Qué escalón te parece que va a ser el más difícil?
- ¿Qué cambiaría en tu vida si este miedo se fuera?

Adaptaciones

Para fobia a las agujas con urgencia: el protocolo de exposición puede acelerarse en una sesión única intensiva (One Session Treatment de Öst).

Para fobia a los truenos: la exposición al sonido grabado en volumen progresivo es muy eficaz y puede hacerse enteramente en el consultorio.

TIPO	Intervención para la vergüenza y la inhibición social en niños de 4 a 7 años con juego y narrativa
EDAD	4 a 7 años
DEMANDA	Vergüenza e inhibición social temprana — niño muy pequeño que esconde la cara, no logra mirar a los ojos, se encoge ante adultos desconocidos, se niega a participar en actividades grupales
DURACIÓN	35 a 40 minutos
MATERIALES	Muñecos o peluches, hoja grande, marcadores

Objetivo

Trabajar la vergüenza y la inhibición social en niños pequeños —manifestación temprana de la ansiedad social que, sin tratamiento, puede consolidarse como ansiedad social clínica en la adolescencia—. La vergüenza emerge hacia los 18 a 24 meses con el desarrollo de la autoconciencia. En niños con temperamento inhibido (Kagan) o en ambientes de alta crítica social, puede volverse crónica. La intervención con niños pequeños no puede ser cognitiva: ocurre a través del juego. Mediante muñecos y narrativas, el niño elabora la vergüenza con la distancia simbólica necesaria para que el contenido no resulte demasiado amenazante.

Cómo aplicar

1

Crear el muñeco tímido (10 min)

«Este es [nombre que elige el niño]. Es un poquito tímido: cuando hay gente nueva cerca, le dan ganas de esconderse. ¿Conocés a alguien así?». Si el niño se identifica, explore con el muñeco como intermediario: «¿Cómo se siente [muñeco] cuando tiene que entrar a una fiesta nueva? ¿Qué hace?». El muñeco crea una distancia simbólica segura para elaborar lo que no puede decir directamente.

2

La narrativa de enfrentamiento (15 min)

Construya con el niño una historia en la que el muñeco enfrenta una situación de vergüenza y sobrevive. Deje que el niño guíe la narrativa, pero ofrezca apoyo cuando el muñeco se trabe: «¿Qué podría hacer [muñeco] ahora? ¿Hay alguien que pueda ayudarlo?». Cuando el muñeco logra enfrentarlo, celebre: «¡Mirá lo que hizo! ¿Y pasó lo que él tenía miedo de que pasara?». Esta narrativa de enfrentamiento exitoso es un ensayo vicario.

3

Generalizar hacia el niño (5 min)

«[Muñeco] tuvo miedo pero igual lo intentó. ¿Vos ya hiciste eso? ¿Alguna vez tuviste vergüenza pero igual fuiste?». Si el niño identifica un momento, celébrelo. Si no, no lo fuerce: la identificación vicaria con el muñeco ya es terapéutica sin necesidad de verbalizarse.

Orientación parental paralela

Oriente a los padres: no llamar «tímido» al niño delante de otros (la etiqueta amplifica la conducta), no forzar una exposición social abrupta, no pedir disculpas por el niño ante los demás. Qué sí hacer: preparar antes de las situaciones sociales nuevas, modelar la propia exposición social de forma explícita y celebrar cada pequeña iniciativa social del niño.

Lectura clínica

Diferencie el temperamento inhibido de la ansiedad social clínica. La inhibición conductual es un rasgo temperamental —los niños inhibidos son más cautelosos, necesitan más tiempo para adaptarse—; no es patología. La ansiedad social clínica es cuando la inhibición produce sufrimiento significativo y compromete relaciones importantes. El tratamiento no tiene por objetivo transformar al niño en extrovertido.

Preguntas orientadoras

- ¿El muñeco se siente igual que vos en alguna situación?
- ¿Qué hizo el muñeco cuando tuvo vergüenza que vos también podrías intentar?
- Cuando te da vergüenza, ¿qué es lo que más quisieras poder hacer?
- ¿Conocés a alguien que te parezca que nunca tiene vergüenza? ¿Qué hace esa persona?
- Si la vergüenza fuera un ruido, ¿cómo sería?

Adaptaciones

Para niños cuyos padres también tienen ansiedad social: el modelado parental es tan importante como la intervención directa.

Para niños de 7 años en adelante con el mismo perfil: transite gradualmente hacia intervenciones cognitivas (recursos 25 y 36 del kit).

TIPO	Técnica de regulación somática por estímulo táctil — alternativa y complemento del grounding visual
EDAD	4 a 10 años
DEMANDA	Ansiedad con dificultad de regulación por vía visual o auditiva — niño que no logra usar el grounding 5-4-3-2-1 en crisis, o que responde mejor a estímulos táctiles
DURACIÓN	30 a 35 minutos — ensayo en sesión; creación de un kit táctil personal
MATERIALES	Objetos de distintas texturas: lija, terciopelo, piedra lisa, esponja, pelotita de goma, arcilla

Objetivo

Desarrollar el anclaje sensorial por el canal táctil como herramienta de regulación emocional. El tacto es el sistema sensorial más primitivo —el primero en desarrollarse en el feto y el más directamente ligado al sistema nervioso autónomo—. La estimulación táctil de textura y temperatura activa vías neurales que compiten con el procesamiento de la amenaza, produciendo redirección atencional y reducción de la activación simpática. La presión profunda en particular activa el sistema parasimpático de forma comparable a la respiración diafragmática —mecanismo documentado por Temple Grandin en el trabajo con estimulación sensorial—.

Cómo aplicar

1

Exploración sensorial (10 min)

Disponga los objetos sobre la mesa sin instrucción inicial: «Podés agarrarlos y explorar. Fijate cómo es cada uno». Observe cómo explora el niño. Pregunte: «¿Hay alguno que te guste más sostener? ¿Por qué? ¿Cómo te sentís cuando lo tocás?». Este mapeo de preferencia táctil revela qué textura tiene función regulatoria para este niño en particular.

2

Crear el ancla personal (10 min)

A partir de la exploración, identifique el objeto que más regula a este niño. Construyan o elijan el objeto-ancha: piedra lisa, trozo de terciopelo, pelotita de goma, pulsera de silicona. El criterio: portátil, discreto y que al niño le guste genuinamente tocarlo. El objeto tiene que ser del niño: él lo elige o lo crea.

3

Instalación del protocolo de uso (10 min)

«Cuando sientas que llega la ansiedad, agarrá [objeto]. Apretalo fuerte 5 segundos. Soltá. Sentí la textura con los dedos, despacio. Respirá mientras explorás la textura». El protocolo combina presión profunda (activación parasimpática) con exploración táctil suave (redirección atencional).

4

Crear el kit táctil completo (5 min)

Para distintos contextos, arme versiones distintas: un objeto pequeño en el bolsillo para la escuela, uno más grande para el escritorio, uno para la mesa de luz. El kit garantiza que el ancla esté siempre disponible en el contexto donde más aparece la ansiedad.

Lectura clínica

Un niño que busca texturas muy intensas puede tener sub-respuesta sensorial táctil. Un niño con aversión intensa a las texturas puede tener hipersensibilidad táctil —común en niños con TDAH, TEA o sensibilidad sensorial atípica—. Los niños que usan el objeto-ancla de forma compulsiva pueden estar desarrollando dependencia del objeto: trabaje gradualmente la tolerancia a no tenerlo.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué textura te calma más? ¿Hay alguna que te ponga más ansioso?
- Cuando apretás el objeto con fuerza, ¿qué notás en el cuerpo después?
- ¿En qué momento del día sería más útil el kit táctil?
- ¿Usaste el objeto-ancla esta semana? ¿Qué pasó?
- ¿Hay alguna textura que busques naturalmente cuando estás ansioso, sin darte cuenta?

Adaptaciones

Para niños con hipersensibilidad táctil severa: trabaje solo con materiales que el niño ya tolera.

Para niños que ya tienen un objeto de apego natural: no lo sustituya; trabaje a partir de lo que ya existe.

TIPO	Protocolo de exposición gradual y reestructuración cognitiva para la ansiedad alimentaria de origen ansioso
EDAD	4 a 10 años
DEMANDA	Ansiedad alimentaria — niño que empezó a evitar alimentos tras un episodio de atragantamiento o vómito; con miedo intenso a tragar; que restringe mucho la dieta por miedo a atragantarse
DURACIÓN	40 a 50 minutos — más exposición gradual a lo largo de las sesiones
MATERIALES	Alimentos de consistencias variadas (traer en las sesiones según la jerarquía), hoja de jerarquía alimentaria

Objetivo

Trabajar la ansiedad alimentaria de origen ansioso —clínicamente distinta de la selectividad alimentaria temperamental y de los problemas orgánicos—, que suele desarrollarse tras un episodio de atragantamiento, vómito intenso o susto con la comida. La fobia a tragar o al vómito (emetofobia) son manifestaciones muy incapacitantes porque afectan una necesidad biológica básica. El niño con emetofobia suele restringir progresivamente la dieta a los alimentos «seguros», baja de peso y ve muy comprometida su calidad de vida.

Cómo aplicar

1

Evaluación y descarte de causa orgánica (previo a la sesión)

Confirme con la familia que la evaluación pediátrica y fonoaudiológica descartó causas orgánicas (reflujo, disfagia mecánica, alergia). Nunca inicie un protocolo de exposición para una dificultad alimentaria sin esa confirmación médica. Mapee el episodio desencadenante: cuándo empezó, qué pasó, qué alimentos o situaciones se están evitando.

2

Psicoeducación sobre el acto de tragar (10 min)

«¿Sabías que tu cuerpo es increíble para tragar? Tragás cientos de veces por día sin darte cuenta. Hay un reflejo automático que protege la tráquea cada vez que tragás. Atragantarse de verdad es muy raro. La mayoría de las veces, cuando la gente cree que se está atragantando, es el reflejo funcionando: la sensación asusta, pero está haciendo exactamente lo que debe».

3

Jerarquía de exposición alimentaria (20 min)

Construya la jerarquía de los alimentos evitados, del menos al más asustador. Organícela por consistencia (líquido, pastoso, sólido blando, sólido firme) o por asociación con el episodio original. Las primeras exposiciones se hacen en sesión: el niño prueba un alimento del escalón más bajo, describiendo lo que siente mientras mastica y traga.

Plan de reintroducción gradual en casa (5 min)

Acuerde un plan específico: qué alimento, en qué comida, en qué contexto. Oriente a la familia a no comentar sobre la comida durante las comidas (la atención amplifica la ansiedad), a no ofrecer alimentos «seguros» como sustituto cada vez que el niño rechaza, y a celebrar con discreción cada nuevo intento.

Lectura clínica

Diferencie la ansiedad alimentaria del ARFID (selectividad alimentaria sin el componente de miedo a consecuencias físicas), que requiere otro protocolo. Cuando la restricción es severa con pérdida de peso, considere una evaluación nutricional paralela y el trabajo conjunto con una fonoaudióloga especializada.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué pensás que va a pasar si comés [alimento evitado]?
- ¿Desde cuándo empezaste a evitar ese alimento? ¿Qué pasó antes?
- Cuando comés los alimentos «seguros», ¿cómo te sentís?
- ¿Hay algún alimento que extrañes comer pero evitás?
- Después de probar el alimento en sesión, ¿qué notaste distinto de lo que imaginabas?

Adaptaciones

Para emetofobia generalizada: el objetivo de la exposición es el miedo a sentir náusea y a vomitar, no alimentos específicos.

Para niños que rechazan por completo la exposición: trabaje psicoeducación y reestructuración cognitiva durante varias sesiones antes. La motivación debe estar establecida primero.

TIPO	Intervención de procesamiento y regulación para ansiedad aguda reactiva a un evento específico reciente
EDAD	4 a 10 años
DEMANDA	Ansiedad reactiva aguda — niño muy ansioso tras un evento puntual (accidente de tránsito, robo presenciado, escena violenta, noticia aterradoras) con hipervigilancia, evitación y pensamientos intrusivos
DURACIÓN	40 a 50 minutos — intervención en las primeras semanas posteriores al evento
MATERIALES	Hoja para la narrativa del evento, marcadores, materiales de regulación disponibles

Objetivo

Intervenir de forma estructurada y temprana en la ansiedad reactiva a un episodio puntual reciente, antes de que la respuesta aguda de estrés se consolide en un cuadro crónico o en TEPT. La mayoría de los niños expuestos a eventos adversos no desarrolla TEPT: procesa el evento gradualmente con el apoyo adecuado y vuelve al funcionamiento basal. La intervención temprana facilita ese procesamiento natural. El modelo de intervención de Bryant fundamenta este recurso: normalización de la respuesta aguda, creación de una narrativa coherente del evento, instalación de recursos de regulación e identificación de factores de riesgo que requieren derivación especializada.

Cómo aplicar

1

Normalización de la respuesta aguda (10 min)

«Lo que pasó fue aterrador. Lo que estás sintiendo ahora —los nervios, los pensamientos que vuelven, las ganas de evitar cosas— es normal después de un susto grande. Tu cerebro está tratando de procesar lo que pasó. Eso lleva un tiempo». No minimice («ya pasó, olvídate») ni catastrofice. La normalización reduce la ansiedad sobre la ansiedad.

2

Construcción de la narrativa del evento (15 min)

Pida que el niño cuente lo que pasó —a su manera, con el nivel de detalle que quiera—. No interfiera durante la narrativa. Al terminar, refleje de vuelta: «Lo que pasó fue [resumen]. Te asustaste mucho. Y después [lo que pasó después]». La narrativa coherente es uno de los mecanismos centrales del procesamiento: las memorias traumáticas son fragmentadas; organizarlas en una narrativa reduce su intrusividad.

3

El presente y la seguridad actual (10 min)

«Lo que pasó fue el [día/semana pasada]. Ahora estás acá, a salvo. El evento pasó, aunque la cabeza todavía lo esté reviviendo». Use anclaje sensorial para reforzar el presente: «¿Qué estás sintiendo ahora? ¿Qué estás viendo acá? Estás a salvo». Especialmente importante para niños con pensamientos intrusivos que hacen sentir que el evento está sucediendo de nuevo.

Instalación de recursos y monitoreo (5 min)

Instale una herramienta de regulación para usar entre sesiones. Acuerde un monitoreo: «Vamos a prestar atención a si los pensamientos que vuelven se hacen menos frecuentes. Si se hacen más frecuentes, o si empezás a evitar más cosas, contame». Ese monitoreo permite detectar tempranamente una progresión hacia TEPT.

Lectura clínica

Indicadores de riesgo de progresión a TEPT: disociación durante o después del evento, reexperiencia muy frecuente (más de una vez por día), evitación generalizada que se amplía, hipervigilancia severa con deterioro del sueño, síntomas que persisten más allá de 4 semanas. Cuando estén presentes, derive a una evaluación especializada en trauma.

Preguntas orientadoras

- ¿Cómo te estás sintiendo ahora en comparación con justo después de que pasó?
- Los pensamientos sobre lo que pasó, ¿vienen con más o con menos frecuencia?
- ¿Hay algo que estés evitando por lo que pasó?
- Cuando viene el pensamiento sobre el evento, ¿qué hacés con él?
- ¿Hay alguien con quien puedas hablar de lo que pasó?

Adaptaciones

Para eventos con violencia o muerte: este recurso ofrece solo primeros auxilios psicológicos. Evalúe el TEPT con un instrumento específico y derive a tratamiento especializado si corresponde.

Para niños cuyos padres también estuvieron expuestos al mismo evento: la regulación de los padres es parte esencial de la regulación del niño.

TIPO	Autorregistro conductual de uso entre sesiones
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	Ansiedad con evitación consolidada — niño que enfrenta pero no reconoce su propio avance
DURACIÓN	Presentación en sesión: 15 min. Uso autónomo diario.
MATERIALES	Cuadernito pequeño u hojas abrochadas organizadas por semana

Objetivo

Los niños ansiosos tienen un sesgo atencional muy particular: perciben con precisión cada momento en que la ansiedad ganó, pero rara vez registran los momentos en que ganaron ellos. Ese sesgo alimenta la creencia de incapacidad que sostiene la evitación. El diario de los pequeños valientes crea un contrapeso deliberado: un registro estructurado de cada enfrentamiento realizado —por más pequeño que sea— que funciona a la vez como refuerzo positivo y como banco de evidencias contra la creencia «no puedo». Se fundamenta en el concepto de autoeficacia de Bandura y en los principios de activación conductual de la TCC.

Cómo aplicar

1

Presentación del diario en sesión (15 min)

«Este diario tiene una misión: registrar cada vez que hacés algo que la ansiedad no quería que hicieras. No hace falta que sea la gran cosa. Puede ser 'hice una pregunta en clase', 'entré al supermercado aunque sentía ese apretón', 'dormí en mi cuarto hasta medianoche antes de ir al de mamá'. Cualquier enfrentamiento cuenta». Proponga tres ítems: (1) qué enfrenté; (2) qué sentí en el cuerpo antes; (3) qué pasó de verdad después de enfrentarlo. Este tercer ítem es el más importante clínicamente: empieza a construir evidencia de que el escenario catastrofizado rara vez se cumple.

2

Uso en las sesiones siguientes (10 min al inicio de cada sesión)

Empiece siempre la sesión leyendo el diario con el niño. Celebre cada registro con curiosidad genuina: «Contame más de este. ¿Qué sentiste cuando te diste cuenta de que lo habías logrado?». Con el tiempo, el diario se vuelve un documento de identidad: el niño que antes se veía como «demasiado ansioso para todo» empieza a verse como «alguien que enfrenta cosas difíciles todos los días».

Lectura clínica

Observe la calidad y la cantidad de registros semana a semana. Las semanas en blanco merecen investigación sin juicio. Atención especial a la columna «qué pasó de verdad después»: cuando el niño empieza a registrar que lo peor no ocurrió, el tratamiento está funcionando.

Preguntas orientadoras

- ¿De qué registro del diario de esta semana estás más orgulloso?
- Cuando mirás todos estos enfrentamientos juntos, ¿qué pensás de vos mismo?
- ¿Hubo algún enfrentamiento que fue más fácil de lo que imaginabas?
- ¿Qué decía la ansiedad que iba a pasar? ¿Qué pasó de verdad?
- Si pudieras mostrarle este diario a alguien, ¿a quién elegirías?

Adaptaciones

Para niños que se resisten a la escritura: reemplázelo por un panel de stickers en la heladera; cada enfrentamiento gana un sticker.

Para niños perfeccionistas que solo registran «grandes» enfrentamientos: calibre activamente qué cuenta como valiente. «¿Te quedaste en el comedor aunque estabas ansioso 10 minutos? Eso cuenta».

TIPO	Actividad cognitiva de categorización con elemento gráfico
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	Ansiedad generalizada, preocupación por eventos futuros incontrolables, niño que intenta controlar todo a su alrededor
DURACIÓN	35 a 45 minutos
MATERIALES	Hoja con dos círculos concéntricos dibujados, marcadores

Objetivo

Trabajar la intolerancia a la incertidumbre —el núcleo cognitivo de la ansiedad generalizada— enseñando al niño a diferenciar lo que está bajo su control de lo que no lo está, y a dirigir su energía solo al primer grupo. Los niños con ansiedad generalizada suelen gastar enorme energía intentando controlar y predecir lo incontrolable. El círculo de control (adaptado del modelo de Stephen Covey al lenguaje infantil) externaliza gráficamente esa distinción y ofrece un criterio práctico: «¿Esto está dentro o fuera de mi círculo?».

Cómo aplicar

1

Presentación de los círculos (5 min)

«El círculo de adentro es lo que podés controlar. El de afuera es lo que no podés controlar, por más que te preocupes. La ansiedad ama hacernos gastar energía en el círculo de afuera, y así quedamos agotados sin resultado». Dé ejemplos concretos: «Cómo estudio para la prueba: círculo de adentro. La nota que me va a poner la maestra: círculo de afuera».

2

Generación de preocupaciones (10 min)

Pida que el niño enumere de 8 a 10 preocupaciones actuales. No filtre ni juzgue. Cuanto más variadas (escuela, familia, salud, amistades), más rico será el ejercicio.

3

Categorización (15 min)

Para cada preocupación, el niño decide: ¿círculo de adentro o de afuera? Para los ítems de afuera: «¿Qué podés controlar dentro de esa situación?». Para los de adentro, proponga una acción concreta. Para los de afuera: «¿Qué podés hacer con la energía que antes iba a esa preocupación?».

4

El plan de acción (5 min)

Para cada preocupación dentro del círculo de control, proponga una acción concreta. Para las de afuera: «¿A dónde puede ir esa energía de forma más útil?». Esa redistribución de energía es el objetivo final.

Lectura clínica

Un niño que pone casi todo en el círculo de afuera tiene muy baja percepción de agencia. Un niño que pone casi todo en el de adentro está sobreestimando su control y puede sentir culpa intensa cuando las cosas se le escapan. El debate más rico suele darse con preocupaciones interpersonales como «que mi mamá esté bien».

Preguntas orientadoras

- Cuando ponés esa preocupación en el círculo de afuera, ¿qué pasa con ella?
- ¿Alguna vez te preocupaste mucho por algo fuera de tu control y pasó igual? ¿Qué hiciste?
- ¿Qué hacés con la energía cuando te das cuenta de que no podés controlar algo?
- ¿Conocés a alguien que parezca bueno para manejar lo incontrolable? ¿Qué hace?
- ¿Qué cambiaría en tu semana si dejaras de gastar energía en el círculo de afuera?

Adaptaciones

Para niños más pequeños (5 a 7 años): simplifique a dos baldes: «el balde de lo que yo puedo hacer» y «el balde de lo que no depende de mí».

Para niños con ansiedad relacionada con la enfermedad de un familiar: identifique lo que sí puede controlar dentro de la situación (visitar, demostrar cariño) sin minimizar la real falta de control.

TIPO	Técnica de distanciamiento psicológico con alter ego — basada en la investigación de Ethan Kross
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Ansiedad con parálisis conductual — niño que sabe qué debe hacer pero «se traba» a la hora de actuar
DURACIÓN	35 a 40 minutos
MATERIALES	Hoja en blanco, marcadores

Objetivo

Usar el mecanismo de distanciamiento psicológico para ayudar al niño a acceder a recursos internos de enfrentamiento que quedan bloqueados cuando está inmerso en su propia ansiedad. La investigación de Ethan Kross muestra que hablar de uno mismo en tercera persona activa circuitos prefrontales asociados a la regulación emocional de forma más eficaz que el foco interno directo. Para los niños, la versión más accesible es el alter ego: crear un personaje valiente y preguntar «¿qué haría este personaje?». El niño que se traba siendo él mismo suele lograr actuar cuando actúa «como» el personaje.

Cómo aplicar

- 1 Creación del personaje valiente (15 min)**

«Vamos a crear juntos un personaje que tenga todas las cualidades que te gustaría tener cuando aparece la ansiedad. Puede ser cualquier cosa: un superhéroe inventado, un animal, un vos del futuro». ¿Cómo se llama?, ¿cómo es?, ¿qué hace cuando tiene miedo?, ¿cuál es su superpoder ante la ansiedad? El niño dibuja y describe con detalle. Cuanto más concreto y personalizado, más eficaz.
- 2 La lógica del personaje (5 min)**

«¿Este personaje también siente ansiedad a veces? ¿Qué hace con eso?». El personaje valiente no es alguien sin ansiedad: es alguien que actúa a pesar de ella. Esa distinción es fundamental: el coraje no es la ausencia de miedo, es la acción frente al miedo.
- 3 Aplicación a situaciones reales (10 min)**

Elija una situación ansiógena real. «¿Qué haría [nombre del personaje] en esta situación?» y «¿Qué te diría antes de entrar?». Deje que el niño responda como el personaje: suele acceder a una sabiduría que no puede alcanzar siendo él mismo.
- 4 El objeto de anclaje (5 min)**

Proponga que el niño cree un símbolo del personaje para llevar consigo —un dibujo pequeño, un botón especial—. En situaciones ansiógenas reales, mirar el símbolo activa el estado mental del personaje. Ese es el mecanismo de ancla conductual.

Lectura clínica

Lo que el niño elige como personaje valiente revela mucho sobre su concepción del coraje. Personajes muy distintos de él pueden indicar que siente el coraje muy lejano. Personajes muy parecidos a él indican mayor integración: pronóstico positivo.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué haría [nombre del personaje] en esta situación que vos no podrías hacer solo?
- ¿Qué cualidad del personaje te gustaría más tener ahora?
- ¿Podés recordar algún momento en que actuaste como el personaje, aunque sea sin darte cuenta?
- ¿Qué te diría el personaje antes de entrar a una situación difícil?
- ¿El personaje también siente miedo? ¿Qué hace con eso?

Adaptaciones

Para niños que eligen personajes de medios conocidos (Spider-Man, Elsa): acéptelo. El distanciamiento es el mecanismo, no la originalidad.

Para niños que dicen «yo nunca voy a ser así»: «¿Qué tendría que pasar para que te parezcas un 10% más a ese personaje?».

TIPO	Técnica de regulación somática por atención plena sensorial — grounding 5-4-3-2-1
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Crisis agudas de ansiedad, ataques de pánico incipientes, disociación leve, niño que «se va del cuerpo» cuando está ansioso
DURACIÓN	20 a 30 minutos — ensayo en sesión; técnica de uso inmediato en crisis
MATERIALES	Ninguno — técnica basada en los sentidos

Objetivo

Enseñar una técnica de anclaje sensorial al momento presente que interrumpe el ciclo de hiperactivación fisiológica durante crisis de ansiedad aguda. El grounding 5-4-3-2-1 es una de las técnicas más eficaces y validadas: al redirigir la atención hacia los estímulos sensoriales del ambiente inmediato, la corteza prefrontal retoma el control sobre la amígdala e interrumpe la respuesta de lucha o huida. Para los niños es especialmente útil porque no exige capacidad cognitiva compleja en el momento de crisis.

Cómo aplicar

1

Presentación y ensayo en sesión (20 min)

«Cuando la ansiedad se hace muy grande, el cuerpo cree que hay un peligro real. Tenemos que mostrarle al cuerpo que está a salvo, y la mejor forma es prestar atención a lo que está acá ahora. Esta técnica usa los 5 sentidos». Practiquen con el ambiente de la sala: 5 cosas que podés VER ahora; 4 cosas que podés TOCAR y sentir su textura; 3 cosas que podés ESCUCHAR; 2 cosas que podés OLER; 1 cosa que podés SABOREAR. Pida que note cómo está el cuerpo después. La mayoría percibe una reducción en menos de 3 minutos.

2

Ensayo con escenario simulado (5 min)

Pida que el niño imagine una situación levemente ansiógena. Cuando diga que está sintiendo algo, proponga el 5-4-3-2-1. Este ensayo con activación leve es fundamental: el cerebro necesita haber practicado el camino para que funcione en una crisis real.

Lectura clínica

Observe si el niño logra mantener la atención en cada sentido. La dificultad para sostener la atención durante el grounding indica un nivel alto de activación y bajo control atencional: hay que trabajar antes técnicas de mindfulness más graduales.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué pasó en tu cuerpo después de hacer los 5 pasos?
- ¿Qué sentido fue más fácil? ¿Cuál fue más difícil?

- ¿En qué situación del día pensás que podrías usar esto?
- ¿Pudiste usarlo en la vida real esta semana? ¿Qué pasó?
- ¿Qué podías ver y escuchar cuando hacías la técnica?

Adaptaciones

Para niños de 4 a 6 años: simplifique a 3-2-1.

Para niños que se ponen más ansiosos al enfocarse en el cuerpo: empiece solo con lo visual (5 cosas que veo). Para el uso en familia: enseñe la técnica también a los padres —un padre que la hace junto al niño es más eficaz que uno que dice «calmate, no es nada».

TIPO	Técnica de externalización narrativa con dramatización y diálogo
EDAD	7 a 10 años
DEMANDA	Ansiedad personalizada — niño que ya hizo el monstruo y está listo para profundizar su relación con la ansiedad
DURACIÓN	40 a 45 minutos
MATERIALES	Opcional: grabador del celular para la «entrevista». Papel para anotar.

Objetivo

Profundizar el trabajo de externalización llevando al niño a una posición de investigación activa frente a su propia ansiedad, en lugar de ser una víctima pasiva. La entrevista usa el formato periodístico: el niño es el reportero y la ansiedad es la entrevistada. Ese reposicionamiento es clínicamente poderoso porque invierte la relación de poder implícita. Fundamentada en principios de la Terapia Narrativa de White y Epston, la técnica también produce psicoeducación naturalista: el niño descubre cómo funciona la ansiedad al «entrevistarla».

Cómo aplicar

1

Preparación de la entrevista (10 min)

«¿Alguna vez te imaginaste entrevistar a tu ansiedad como si fueras un reportero? Hoy yo voy a ser el reportero y vos vas a ser la ansiedad. Respondés como si fueras ella». Ayude al niño: ¿cómo habla la ansiedad?, ¿tiene una voz?, ¿es gruesa, fina, rápida? Si el niño ya creó el Monstruo, use sus características como base.

2

La entrevista (20 min)

Guion de preguntas: «Ansiedad, ¿te podés presentar? ¿Cuándo apareciste en la vida de este niño?» / «¿Cuál es tu objetivo?» / «¿En qué situaciones aparecés más?» / «¿Qué hacés para llamar la atención?» / «¿Tenés algún punto débil?» / «¿Qué pasa cuando él te enfrenta igual?» / «¿Hay algo que quisieras que él supiera?». Grabe si el niño acepta.

3

Salir del personaje y procesar (10 min)

«¿Qué fue lo más sorprendente de esta entrevista?» / «¿Hubo alguna respuesta que no esperabas?» / «Ahora que la conocés mejor, ¿qué cambia?». Este procesamiento consolida los insights de la dramatización en aprendizaje consciente.

Lectura clínica

La respuesta a la pregunta «¿cuál es tu objetivo?» suele ser la más reveladora. Una ansiedad que «quiere protegerme» o «no quiere que me lastime» abre espacio para una relación menos adversarial: en lugar de «necesito eliminar la ansiedad», el niño empieza a desarrollar «necesito aprender a escucharla sin dejar que mande».

Preguntas orientadoras

- ¿Qué aprendiste sobre tu ansiedad que no sabías antes?
- ¿Cuál fue la respuesta que más te sorprendió?
- Ahora que conocés sus puntos débiles, ¿qué cambia?
- ¿Te parece que la ansiedad intenta ayudarte de alguna forma, aunque también moleste?
- ¿Qué te gustaría responderle a ella ahora?

Adaptaciones

Para niños que no quieren hacer el papel de la ansiedad: invierta —el niño es el reportero y usted hace el papel de la ansiedad—.

Para niños más grandes: proponga que escriban la entrevista como un artículo de diario.

TIPO	Planificación de actividades placenteras con función de activación conductual
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Ansiedad con estrechamiento de la vida — niño que progresivamente abandonó actividades que disfrutaba para evitar la ansiedad asociada
DURACIÓN	35 a 40 minutos
MATERIALES	Hoja con el dibujo de una batería o pila de energía, marcadores

Objetivo

Revertir el estrechamiento de la vida que produce la ansiedad cronicada. La activación conductual, basada en los principios de la TCC para la depresión y la ansiedad, propone aumentar deliberadamente la frecuencia de actividades placenteras y de dominio, independientemente del estado emocional. La metáfora de la batería lo vuelve accesible: el niño identifica qué «le carga la pila» y planea cómo poner más de esas cosas en la semana.

Cómo aplicar

1

Mapeo de la batería actual (10 min)

Muestre una batería de 0% a 100%: «¿Cómo está tu batería esta semana?». Después: «¿Qué te drena la batería?» y «¿Qué te la carga?». Observe qué incluye el niño y qué deja afuera. Las actividades que antes disfrutaba pero dejó de hacer por ansiedad rara vez aparecen de forma espontánea.

2

El inventario de placer (10 min)

Construya una lista amplia de actividades placenteras —incluyendo las que ya hace y las que disfrutaba pero dejó—. Pregunte: «¿Hay algo que hacías antes y dejaste? ¿Por qué?». Esto suele revelar el mapa de la evitación sin que el niño lo note.

3

El plan de carga (10 min)

Elijan tres actividades para la semana siguiente: una pequeña (que puede hacer sola en cualquier momento), una mediana (requiere esfuerzo) y una desafiante (implica algún nivel de ansiedad). Sea específico: no «tratá de hacer algo lindo» sino «el miércoles después de la escuela vas a dibujar 20 minutos antes de hacer la tarea».

Lectura clínica

Los niños con ansiedad severa suelen tener una lista de drenajes mucho mayor que la de cargadores. Cuando la lista de cargadores está muy vacía: «Antes de que la ansiedad se hiciera tan grande, ¿qué hacías que te gustaba?». La reintroducción gradual de ese repertorio es esencial.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué actividad sentís que la ansiedad te hizo abandonar y que más extrañas?
- ¿Cuándo fue la última vez que tu batería estuvo realmente llena?
- ¿Qué necesitás para poder hacer la actividad desafiante?
- Después de hacer una actividad que te carga la batería, ¿cómo quedás?
- ¿Hay alguna actividad que siempre pensaste que te gustaría pero nunca probaste?

Adaptaciones

Para niños que dicen «no me gusta nada»: no lo acepte como definitivo, es un síntoma. Si realmente no identifica nada, es un indicador de anhedonia que requiere evaluar una depresión asociada.

Para niños con agenda muy cargada pero aun así ansiosos: el problema puede ser el exceso de demanda; trabaje eliminando compromisos que drenan.

TIPO	Protocolo de orientación parental específico para ansiedad infantil
EDAD	Padres y cuidadores de niños de 4 a 10 años
DEMANDA	Uso obligatorio cuando el ambiente familiar está reforzando la evitación — algo muy común y rara vez intencional
DURACIÓN	50 a 60 minutos — sesión exclusiva con el adulto
MATERIALES	Ninguno obligatorio. Opcional: guion impreso con las orientaciones principales

Objetivo

La conducta de ansiedad y evitación en los niños se mantiene, en gran parte, por las respuestas del ambiente. Dos patrones parentales son especialmente problemáticos: (1) la sobreprotección ansiosa —padres que retiran sistemáticamente los estímulos ansiógenos, reforzando negativamente la evitación—; (2) la invalidación —padres que minimizan o se angustian tanto que transmiten que la situación es de verdad peligrosa—. Este recurso enseña la postura de «andamiaje»: presencia de apoyo sin retirar el desafío, la conducta parental más asociada a buenos resultados.

Cómo aplicar

1

Psicoeducación sobre el ciclo de la ansiedad y la evitación (15 min)

«Cuando el niño se pone ansioso y evita, siente alivio inmediato. Ese alivio le enseña al cerebro que evitar funciona. La próxima vez, la ansiedad aparece más fuerte, la evitación es mayor y el ciclo se repite. Cuando los padres retiran el estímulo —lo dejan no ir a la escuela, no fuerzan la situación— ayudan a mantener el ciclo, aun con buena intención». Use la metáfora del músculo: «El coraje es como un músculo. Si nunca lo ejercitamos porque tenemos miedo de que duela, se atrofia».

2

Qué hacer y qué no hacer (20 min)

NO HACER: preguntar una y otra vez «¿estás bien?» (reactiva la ansiedad y señala peligro); prometer sacarlo de la situación antes de intentar; discutir mucho durante la crisis. SÍ HACER: validar el sentimiento sin validar la evitación —«Sé que es difícil. Sé que tenés miedo. Y sé que podés»—. Acordar un plazo, no una condición —«Vas a quedarte 20 minutos. Después evaluamos»—. Celebrar activamente cada enfrentamiento, por más pequeño que sea.

3

La ansiedad contagiosa (10 min)

Con cuidado y sin culpabilizar: «Las investigaciones muestran que los hijos de padres ansiosos tienen mayor riesgo de desarrollar ansiedad —no solo por genética, sino por modelado de conducta—. ¿Hay alguna situación que ustedes también eviten por ansiedad y que pueda estarle enseñando algo al niño?».

Lectura clínica

Identifique el patrón parental predominante antes de la sesión: sobreprotección o invalidación. El padre sobreprotector necesita entender que el alivio inmediato está perjudicando a largo plazo, y muchas veces necesita apoyo para su propia ansiedad. El padre invalidador necesita aprender sobre la experiencia real del niño.

Preguntas orientadoras para los padres

- Cuando el niño se pone ansioso, ¿qué suelen hacer?
- ¿Hay alguna situación que le dejan evitar porque es más fácil para todos?
- ¿Qué sienten cuando el niño está en crisis? ¿Qué les pasa por la cabeza?
- ¿Se ven a ustedes mismos en alguna de las cosas que hace el niño cuando está ansioso?
- ¿Qué necesitarían para poder estar presentes cuando él está en crisis?

Adaptaciones

Para padres con ansiedad severa no tratada: la orientación parental tiene un límite. Derive a tratamiento propio.

Para padres muy sobrecargados: adapte las orientaciones a lo posible dentro de la rutina real.

TIPO	Actividad de construcción de identidad narrativa basada en competencias
EDAD	6 a 10 años
DEMANDA	Ansiedad con baja autoeficacia percibida, niño que generaliza fracasos e ignora éxitos, creencia nuclear de incapacidad
DURACIÓN	40 a 50 minutos — construcción inicial en sesión; ampliación en las semanas siguientes
MATERIALES	Hojas A4 abrochadas formando un álbum o cuadernillo, marcadores, fotos opcionales

Objetivo

Construir un banco de evidencias concreto y visual que refute la creencia nuclear «no puedo». Los niños ansiosos presentan un sesgo cognitivo de memoria selectiva para los fracasos: recuerdan con detalles vívidos cada vez que la ansiedad los paralizó y tienen una memoria empobrecida de los momentos en que lograron enfrentarla. El álbum crea deliberadamente un contrapunto: un registro físico, concreto y permanente de competencias, enfrentamientos y superaciones.

Cómo aplicar

1

Creación y primeras páginas (40 min)

«Este álbum va a guardar todas las veces que lograste hacer algo que la ansiedad no quería que hicieras. Empecemos hoy recordando algunas». Cada página: título del logro, cuándo pasó, qué sintió antes y después, y un dibujo. Destrahe recuerdos con preguntas: «¿Alguna vez fuiste a un lugar nuevo y estuviste bien?», «¿Hablaste con alguien que no conocías?», «¿Diste una prueba que te daba miedo y te fue bien?».

2

Ampliación continua (10 min por sesión)

Empiece cada sesión preguntando: «¿Qué hiciste esta semana que pueda entrar en el álbum?». Cuando el niño llegue diciendo «no puedo con esto», pídale que abra el álbum y lea tres páginas al azar. A menudo eso basta para romper el estado de desesperanza del momento.

Lectura clínica

Un niño con dificultad extrema para recordar cualquier situación en que le fue bien tiene la memoria de competencia muy bloqueada: indica una creencia nuclear consolidada que requiere trabajo cognitivo más profundo. El propio proceso de buscar ejemplos con la ayuda del psicólogo ya es una intervención.

Preguntas orientadoras

- Cuando mirás este álbum, ¿qué pensás de vos?
- ¿Qué página fue la más difícil de poner acá?
- ¿Hay algo en este álbum que no recordabas haber hecho?

- Si el niño del comienzo del tratamiento viera este álbum hoy, ¿qué pensaría?
- ¿Qué querés poner acá dentro de tres meses?

Adaptaciones

Para niños perfeccionistas que solo quieren «grandes logros»: calibre que los pequeños enfrentamientos cuentan más, porque ocurren todos los días.

Para niños en fase de cierre: el álbum puede ser el producto que se llevan a casa como síntesis del proceso.

TIPO	Técnica cognitiva de calibración de probabilidad y magnitud
EDAD	8 a 10 años
DEMANDA	Ansiedad con catastrofización intensa — niño que siempre imagina el peor escenario posible como el más probable
DURACIÓN	35 a 45 minutos
MATERIALES	Hoja con dos termómetros paralelos: probabilidad (0 a 100%) y magnitud (0 a 10)

Objetivo

Trabajar las dos distorsiones cognitivas centrales de la catastrofización: la sobreestimación de la probabilidad y la sobreestimación de la magnitud. El barómetro usa dos escalas separadas para volver visible la distinción entre «probabilidad de que ocurra» y «qué tan terrible sería si ocurriera», que el niño ansioso colapsa en una única evaluación de «esto es catastrófico». Al separar los dos ejes, se abre espacio para intervenir en cada uno de forma independiente.

Cómo aplicar

1

Presentación de los dos barómetros (5 min)

«Cuando nos ponemos ansiosos, el cerebro mezcla dos cosas distintas: la chance de que algo malo pase y lo malo que sería si pasara. Hoy vamos a separar esas dos cosas». El de la izquierda mide probabilidad (0% a 100%). El de la derecha mide magnitud (0 = puedo manejarlo fácil, 10 = sería devastador).

2

Aplicación a escenarios ansiógenos (20 min)

Elija 3 situaciones típicas. Para cada una, el niño marca los dos barómetros. Después investigue: para la probabilidad —«¿Qué evidencia hay de que esto va a pasar? ¿Cuántas veces pasaste por esto y de verdad ocurrió lo peor?»—. Para la magnitud —«Si pasara, ¿qué harías? ¿Ya pasaste por algo difícil y lograste manejarlo?»—.

3

La recalibración (10 min)

Después de investigar, pida que el niño vuelva a marcar los barómetros con números revisados. Muestre la diferencia: «Antes estaba en 90%, ahora lo pusiste en 30%. ¿Qué cambió?».

Lectura clínica

Un niño que marca probabilidad muy alta pero magnitud moderada tiene sobre todo una distorsión de probabilidad: trabaje el empirismo. Un niño que marca probabilidad baja pero magnitud altísima tiene sobre todo intolerancia al malestar: trabaje la construcción de tolerancia y la identificación de recursos de enfrentamiento.

Preguntas orientadoras

- ¿Cuántas veces pasaste por esa situación y de verdad ocurrió lo peor?
- Si pasara lo peor, ¿qué harías? ¿Quedarías destruido para siempre?
- ¿Hay alguien que podría ayudarte si pasara lo peor?
- ¿Cuál es el escenario más realista —no el peor posible, sino el más probable?
- ¿Ya sobreviviste a situaciones difíciles antes? ¿Cómo hiciste?

Adaptaciones

Para niños de 6 a 7 años: reemplace los porcentajes por imágenes —de sol a nube para la probabilidad y de hormiguita a dinosaurio para la magnitud—.

Para niños con ansiedad de salud: la magnitud tiende a ser siempre máxima. Trabaje primero la probabilidad.

TIPO	Ritual de cierre terapéutico con síntesis de aprendizajes y plan de mantenimiento
EDAD	5 a 10 años
DEMANDA	Fase final del acompañamiento — cuando hay reducción consistente de los síntomas y ampliación del repertorio de enfrentamiento
DURACIÓN	50 a 60 minutos
MATERIALES	Todos los materiales producidos durante el acompañamiento + hoja nueva para el kit de herramientas

Objetivo

Consolidar los logros en un cierre que: (1) revise el recorrido y fortalezca la identidad de «alguien que aprendió a manejar la ansiedad»; (2) construya un plan de mantenimiento concreto; (3) desmitifique la recaída. Indicadores de preparación para el alta: reducción significativa en los termómetros; niño que enfrenta situaciones antes evitadas sin asistencia constante; generalización a nuevos contextos; familia con una postura de andamiaje establecida.

Cómo aplicar

1

Revisión del recorrido (15 min)

Organice sobre la mesa todos los materiales: el monstruo, la escalera del miedo, los barómetros, el diario de los pequeños valientes, el álbum de las veces que lo logró, el termómetro con todas sus marcas. Recórralos uno a uno: «¿Qué te acordás de cuando hicimos esto?» y «¿Qué representa este material de tu camino?». Deje que el niño conduzca.

2

El kit de herramientas (15 min)

Hoja nueva llamada «Mi kit de herramientas». El niño escribe las estrategias que más le funcionaron — no las que usted enseñó, sino las que siente que son suyas—. Pregunte: «Si pudieras llevarte solo tres cosas de este tratamiento, ¿cuáles serían?».

3

El plan de mantenimiento y la recaída (10 min)

«Es posible que en algún momento la ansiedad vuelva más fuerte. Eso no es un fracaso: es normal». Construyan juntos un plan: a quién avisar, qué herramienta usar primero, cuándo volver a buscar ayuda profesional.

4

Despedida y puerta abierta (10 min)

Celebre el recorrido: «Te vi enfrentar cosas que al principio parecían imposibles. Eso fuiste vos, no yo». Aclare que la puerta queda abierta: «Si la ansiedad vuelve de una forma que las herramientas no alcanzan a manejar, volver acá no es debilidad: es inteligencia».

Lectura clínica

Observe cómo responde el niño a la idea de cierre. La ansiedad de separación puede emerger justamente al final, lo cual es clínicamente significativo. Nómbrelo: «Veo que hablar de terminar está generando un poco de ansiedad. ¿Qué estás sintiendo?». Ese momento de aplicación en vivo suele ser el más consolidador de todo el tratamiento.

Preguntas orientadoras

- ¿Qué cambió en vos desde que empezamos?
- ¿Qué aprendiste sobre tu ansiedad que no sabías antes?
- Si la ansiedad vuelve fuerte, ¿cuál es la primera cosa que vas a hacer?
- ¿Qué le dirías a un niño que está empezando ahora?
- ¿Hay alguien a quien quieras contarle lo que aprendiste acá?

Adaptaciones

Para niños con historial de abandono o pérdida: el cierre tiene un peso extra. Amplíe las sesiones de transición.

Para cierres por cambio de terapeuta o límite de sesiones: sea honesto —«Paramos por ahora por [razón], no porque ya no necesites ayuda».